



ЛІКАРНЯ
ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ
ОНКОЛОГІЇ

Відділення променевої діагностики
Позитронно-емісійна томографія об'єднана із комп'ютерною томографією із 18F-ФДГ

Пацієнт Жерліцина Анастасія Станіславівна
ID 110889

Дата народження 25-04-1976

Дата дослідження 17-08-2023

Методика дослідження

Проведено ПЕТ/КТ сканування від рівня орбіт до середини стегон через 60 хвили після внутрішньовенного введення 10.9 мКі 18F-ФДГ. Рівень глікемії перед введенням РФП - 5.7 ммоль/л.

КТ сканування проведено із внутрішньовенним контрастуванням. Проведено додаткове сканування на рівні грудної клітки із затримкою дихання. Загальна DLP 1497 mGy*cm.

Корекція аттенюації ПЕТ зображень проведена на основі КТ даних.

Стандартизовані показники накопичення РФП нормалізовані за вагою пацієнта (SUV).

Мета дослідження/клінічні дані

Контрольна радіологічна оцінка після проведеного лікування

Дані попередніх досліджень для порівняння/кореляції
ПЕТ-КТ з ФДГ 11-04-2023

Знахідки:

Голова та шия

Як і при попередній візуалізації, гіперметаболических змін типових для метаболічно активного агресивного неопластичного ураження не знайдено; без суттєвої динаміки.

Грудна клітка

Як і при попередній візуалізації, гіперметаболических змін типових для метаболічно активного агресивного неопластичного ураження не знайдено; попередньо візуалізовані дрібні легеневі вузлики стабільні, помітно декілька нових дуже дрібних субплевральних вузликів, наприклад ліворуч у косої плевральної щілини в верхній частці 2-3 мм.



ЛІКАРНЯ
ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ
ОНКОЛОГІЇ

Збільшилися елементи тимусу, до 23 мм товщиною, мають солідно-жирову структуру та лямбдоподібну конфігурацію, демонструють помірну дифузну активність, без окремих гіперметаболических вузлів.

Живіт і таз

Попередньо візуалізовані численні маси в печінці практично повністю втратили свої активні периферичні солідні компоненти, інтенсивність накопичення ФДГ по периферії мас не перевищує істотно активність печінкового пулу, частина зменшила свої загальні розміри, правій частці з 19 до 16 см, у лівій частці з 7.5 до 5.0 см.

Нових гіперметаболических осередкових уражень в паренхімі печінки не знайдено.

Відома маса з стінки шлунку також втратила солідні компоненти, наразі практично рідинна та не демонструє підвищеного накопичення ФДГ, також і зменшилася з 58 до 44 мм.

Збільшилися неактивні маси у матці, наприклад, відносно краніальніша/більше з 72 до 96 мм, як і при попередній візуалізації, демонструють низьку активність, структура їх без динаміки.

В іншому, без істотної динаміки, нових активних/підозрілих уражень не знайдено.

Кістки та м'які тканини

Як і при попередньому дослідженні, гіперметаболических кісткових уражень не знайдено, агресивних за структурними/КТ ознаками кісткових уражень не знайдено

Радіологічний висновок:

Порівняно із 11-04-2023, втрата активності та периферичних солідних компонентів мас в шлунку та печінці, на користь відповіді GIST на терапію Глівеком. Помірне збільшення неактивних вузлів у матці, без зміни їх структури.

Дуже дрібні поодинокі нові вузлики у легенях, для контролю.

З повагою, Новіков М. Є.

лікар радіолог,

завідувач відділенням променевої діагностики

Лікарні Ізраїльської Онкології LISOD